

УДК: 618.146-006.6:076.4

М.Н.Сандыбаев, Т.А. Адылханов, З.А.Манамбаева, Т.П. Бань, К.Б.Шалаганова, Ж.Н.Кыдырбаева,
Ж.Д.Суртаева, А.Т.Сулейменова

КГП на ПХВ «Региональный онкологический диспансер г. Семей»

Цитологический метод в ранней диагностике рака шейки матки

Аннотация. РОД г. Семей проведен анализ работы цитологического метода исследования для онкоцитологического скрининга и оппортунистического профилактического осмотра за 2008 – 2013 годы. Анализ показал эффективность скрининга в выявлении ранних форм рака(0.2%), одновременно доказана необходимость оппортунистического профилактического осмотра.

Ключевые слова: рак шейки матки, диагностика, скрининг, онкоцитология.

Актуальность

Рак шейки матки (РШМ) относится к наиболее распространенным и социально значимым онкологическим заболеваниям. Ежегодно в мире диагностируются до 500 тысяч новых случаев РШМ[1]. В настоящее время успех по обеспечению здоровья населения зависит от проведения массовых профилактических осмотров. В Республике Казахстан профилактика РШМ носила оппортунистический характер, рутинный осмотр на зеркалах и взятие мазков на цитологическое исследование приспособленными инструментами. Цитологические мазки окрашивались по методу Романовского-Гимзе. Только с 2005 года скрининг РШМ был включен в Государственную программу реформирования и развития здравоохранения Республике Казахстан.

Цель исследования

- анализ эффективности организованного цитологического скрининга и оппортунистического профилактического осмотра и использования метода жидкостной цитологии и полихромной окраски (пап-тест) как наиболее информативного в отношении выявления ранних стадий рака шейки матки.

Материалы и методы исследования

- анализы годовых отчетов цитологической лаборатории г. Семей.

2005 год: 20-34 года

2006-2007 года 18-49 лет

С 2008 года 35,40,45,50,55,60 лет.

В ходе проведения данного вида исследований было обследовано в 2006 году 145249 женщин, 2007 году -138684, в 2008 году - 22630, 2009 году - 18311, 2010 году - 17852, 2011 году - 20400, 2012 году - 20013 и в 2013 году - 11300.

Материал для исследования получали с помощью Cervix – Brush, метод окраски препаратов-по Романовскому

- Гимзе в 2006-2007 годах. 2008 году — 60% всех исследований окрашены по методу Папаниколау и 40% по Романовскому - Гимзе. С 2009 года все скрининговые исследования в 100% случаев окрашиваются по методу Папаниколау (пап-тест). Цитологические заключения интерпретируются по терминологии Бетесда.

Цитологический скрининг РШМ постоянно совершенствуется и с 2013 года начато применение метода жидкостной цитологии. Для эффективного проведения скрининга было организовано проведение выездных мастер-классов совместно с врачами онкогинекологами, цитологами по обучению правильной технологии взятия цитологического материала по методу жидкостной цитологии с использованием цито-щетки Brush. В работе руководствовались алгоритмами обследования и последующего лечения выявленной патологии, разработанной Казахским научно-исследовательским институтом онкологии и радиологии. Параллельно со скринингом цитологическим исследованием целевых групп по Семейскому региону проводится профилактический осмотр женщин, которые не вошли в целевые группы - оппортунистический профилактический осмотр. Забор материала в данных случаях проводился щеткой цито - Браш. Материал и окрашивался по методу Романовского-Гимзе.

Результаты исследования

В рамках проведения оппортунистического профилактического осмотра рака шейки матки было обследовано 2008 году 34699 женщин, 2009 году - 39586, 2010 году - 35279, в 2011 году - 34855, в 2012 году -34659 и в 2013 году - 38846.

Таблица 1 - Количество больных раком шейки матки, выявленных по скрининговому осмотру

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ca in situ	6	4	5	11	19	9
Микро инвазивный рак	2	14	3	8	15	18
Инвазивный	8	11	10	10	3	3
Всего	10	25	13	18	18	21
% ранних раков (Cainsitu+ микро)	0.03	0.09	0.004	0.09	0.16	0.2

Из таблицы 1 видно, что выявляемость ранних раков в ходе проведения скринингового осмотра рака шейки матки увеличивается от 0.03% до 0.2%.

Данные, представленные в таблице №2, свидетельствуют о достоверном повышении процента выявленных злокачественных процессов шейки матки с 0.007 до 0.1 %.

Таблица 2 - Результаты оппортунистического профилактического осмотра

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cainsitu	0	1	4	3	8	10
Микро инвазивный рак	0	2	3	4	8	29
Инвазивный	8	15	19	32	24	31
Всего	8	17	22	36	32	60
% ранних раков (Cainsitu+микро)	0	0.007	0.02	0.02	0.04	0.1

Обсуждение

По результатам проведенного анализа эффективности цитологического скрининга было установлено, что решающим фактором, влияющим на эффективность скрининга и оппортунистического профилактического осмотра, является адекватность забора мазка, широта охвата женского населения [2,3]. Проведение обучающих семинаров, мастер-классов для гинекологов и акушеров звена первичной медико-санитарной помощи позволило снизить количество неинформативных для постановки диагноза мазков, следовательно, позволило получить более качественный цитологический материал и диагностировать более высокий процент ранней патологии шейки матки.

Ранние раки были в большинстве случаев выявлены по скринингу при окраске по методу Папаниколау и забором материала с применением метода жидкостной цитологии, что еще раз подтверждает преимущество данной методики при проведении скрининга. Большая роль в эффективности скрининга и оппортунистического профилактического осмотра отводится квалификации врача-цитолога и цитотехника.

Выводы

В целом процент выявляемости РШМ на ранних стадиях с каждым годом увеличивается как по скринингу, так и по оппортунистическому профилактическому осмотру. Процент выявленных ранних раков превалирует при скрининге, проведенном методом жидкостной цитологии и окрашенных по методу Папаниколау. Таким образом, проведенный анализ доказывает необходимость проведения цитологического скрининга как организованного так и оппортунистического, причем процент выявления ранних раков гораздо выше при организованном скрининге. Еще раз подтверждается преимущество полихромной окраски (пап-тест) перед монохромной окраской по Романовскому-Гимзе и внедрения метода жидкостной цитологии. Шестилетний опыт организованного цитоло-

гического скрининга в Республике Казахстан, предусмотренный Программой развития здравоохранения, свидетельствует о правильном организационно-методическом подходе к работе широкой сети смотровых кабинетов, что способствует уменьшению заболеваемости и смертности от рака шейки матки.

Список литературы

- 1 Цитологический скрининг рака шейки матки в Республики Казахстан /Методические рекомендации.-Алматы.- 2008.- С.5-7.
- 2 Новик В.И. Факторы эффективности цитологического скрининга рака шейки матки // Российский онкологический журнал.-2006.- № 1.- С 47-49.
- 3 Годовые отчеты цитологической лаборатории РОД г. Семей за 2005-2013годы.

Тужырым

М.Н.Сандыбаев, Т.А. Адылханов, З.А.Манамбаева, Т.П. Бань, К.Б.Шалаганова, Ж.Н.Кыдырбаева, Ж.Д.Суртаева, А.Т.Сулейменова

Региональды онкологиялық диспансер Семей қ.

Цитологиялық зерттеу жатыр мойны обырының алдын алу

Семей қаласының ӨОД бойынша 6 жылға (2008 – 2013) профилактикалық цитологиялық тексерулерге талдау жүргізіледі. Аталмыш талдау ұйымдастырылған скрининг жатыр мойны обырын ерте анықтауда анағұрлым тиімді екенін көрсетті (0.2%). Бірақ оппортунистік скринингтің тиімділігі мен қажеттілігі дәлелденген.

Түйінді сөздер: жатыр мойнының қатерлі ісігі, диагностика, скрининг, онкоцитология.

Summary

M.Sandybaev, T.Adykhanov, Z.Manambaeva, T.Ban, K.Shalaganova, Zh.Kudirbaeva, Zh.Surtaeva, A.Suleimenova
MSE on PVC «Regional Oncology Center of Semey»

Screening is the main technique in cervical cancer prevention

Cytological and preventive examinations of the last six years (2008-2013), Regional Oncology Center of Semey were analyzed. The analyses tells that organized screening is more effective when treatment of cervical cancer (0.2%). Effectiveness and necessity of opportunistic screening have been proved.

Key words: cervical cancer, diagnosis, screening, oncocytology.